

Giải Đáp 5 Câu Hỏi Trọng Tâm Về Tăng Sản Điện Hình & K Vú

Thời điểm: Tháng 09/2026
Chuyên khoa: Ung Bướu & Giải Phẫu
Bệnh
Mã chuyên đề: MOM-PDF-04-QA5

Medical Disclaimer: Tài liệu được tổng hợp và đối chiếu từ: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (Uterine Neoplasms & Breast Cancer), ACOG Practice Bulletin No. 232, RCOG Joint Guideline No. 67 và Phác đồ Bệnh viện Từ Dũ & Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM.

CÂU HỎI 1: Tăng sản điện hình là tế bào vẫn bình thường hay tế bào biến đổi bất thường?

Trả lời: **TẾ BÀO VẪN HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG (LÀNH TÍNH)!**

- Bản chất tế bào:** "Tăng sản điện hình" (tiếng Anh y khoa: *Endometrial Hyperplasia Without Atypia*) có nghĩa là số lượng các ống tuyến sinh sôi dày đặc hơn bình thường, nhưng **cấu trúc nhân tế bào vẫn đồng đều, phân cực nguyên vẹn, hoàn toàn KHÔNG CÓ ĐỘT BIẾN DỊ DẠNG ÁC TÍNH (Without Atypia)**.
- Mô tả trên phiếu GPB BV Hùng Vương:** "Các tuyến được lót bởi thượng mô trụ cao... nhân tăng sắc nhẹ" → Đây là hình ảnh tế bào trụ sinh lý bình thường của niêm mạc tử cung đang trong pha phân bào hoạt động dưới tác động của hormone.
- Mức độ an toàn:** Nguy cơ tiến triển thành ung thư **cực kỳ thấp (< 1% đến 3%)**, được y khoa xếp vào nhóm **thương tổn lành tính**, tuyệt đối **không phải ung thư** và **không phải tổn thương tiền ung thư (EIN)**.

CÂU HỎI 2: Tăng sản này có phải do Tamoxifen? Có tự thoái triển không hay bắt buộc điều trị?

- Có phải do Tamoxifen không? → ĐÚNG 100%.** Tamoxifen là chất điều hòa thụ thể Estrogen chọn lọc (SERM). Tại tuyến vú thuốc ức chế tế bào ung thư, nhưng tại lòng tử cung thuốc có tác dụng kích thích nhẹ (chủ vận một phần) làm giãn nang tuyến niêm mạc và hình thành các mảng tăng sản dạng bục (Swiss-cheese appearance).
- Nó có tự động giảm dần theo thời gian không? → CÓ.** Sau khi ngừng Tamoxifen tháng 1/2026, kích thích nội tiết này mất đi, niêm mạc sẽ bước vào quá trình tự thoái triển mô học tự nhiên.
- Có bắt buộc phải điều trị không?**
 - Nếu không có triệu chứng ra máu: Hoàn toàn có thể chỉ theo dõi định kỳ mà không cần can thiệp.
 - Tuy nhiên ở trường hợp của bệnh nhân: Đang có tình trạng **rong kinh kéo dài** cộng hưởng với **khối u xơ 45mm và Adenomyosis** làm mất máu dẫn đến nguy cơ thiếu máu mạn tính → Do đó **cần can thiệp điều trị** để cầm máu và bảo vệ sức khỏe.

CÂU HỎI 3: Thời gian theo dõi thoái triển là bao lâu? Thời gian biến đổi nặng hơn là bao lâu?

Mục Tiêu Theo Dõi	Khung Thời Gian	Diễn Biến Thực Tế & Hướng Xử Trí
Thời gian cho phép theo dõi sự thoái triển	3 đến 6 Tháng (Tối đa 12 tháng)	Kiểm tra siêu âm đầu dò sau mỗi 3 tháng. Đa số các trường hợp tăng sản do Tamoxifen sẽ tự thoái triển hoặc đào thải hết trong vòng 6–12 tháng sau khi ngưng thuốc.
Thời gian để biến đổi nặng hơn (nếu có)	5 đến 10 Năm (Rất hiếm gặp, < 1–3%)	Để một mảng tăng sản điện hình tích lũy đột biến thành ác tính cần từ 5–10 năm tiếp xúc liên tục với Estrogen không đối kháng mà bị bỏ mặc hoàn toàn. Bệnh nhân đã phát hiện sớm và có kế hoạch xử lý nên nguy cơ này gần như bằng 0 .

CÂU HỎI 4: Muốn theo dõi sự thoái triển thì cần làm những bước gì để biết?

Quy trình theo dõi chuẩn mực theo hướng dẫn của ACOG và Bệnh viện Từ Dũ / BV Hùng Vương gồm 3 bước:

- Bước 1 - Theo dõi triệu chứng lâm sàng (Hàng tháng):** Ghi nhận tính chất chu kỳ kinh nguyệt và mức độ chảy máu âm đạo. Nếu lượng máu kinh giảm dần, chu kỳ ổn định trở lại là dấu hiệu lớp niêm mạc đang tự thoái triển thuận lợi.
- Bước 2 - Siêu âm Doppler phụ khoa qua ngả âm đạo (Mỗi 3 tháng/lần):**
 - Đo bề dày nội mạc tử cung (Endometrial Thickness - ET): Sau khi ngưng Tamoxifen, bề dày niêm mạc sẽ mỏng dần (lý tưởng < 5–8mm ở giai đoạn đầu chu kỳ).
 - Khảo sát ranh giới giữa nội mạc và cơ tử cung, kiểm tra Doppler dòng mạch máu nuôi dưỡng xem có tăng sinh mạch bất thường hay không.
- Bước 3 - Nội soi buồng tử cung (Hysteroscopy) hoặc Sinh thiết lại (Nếu cần):** Chỉ định khi sau 3–6 tháng tình trạng rong kinh vẫn không dứt hoặc niêm mạc tử cung không mỏng đi trên siêu âm. Bác sĩ đưa camera vào quan sát trực tiếp toàn bộ lòng tử cung và bấm mẫu mô kiểm tra lại.

CÂU HỎI 5: Với bệnh nhân K vú thể nội tiết thì phác đồ điều trị tăng sản này như thế nào?

Nguyên tắc vàng: Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tuyến vú (không làm tăng nguy cơ tái phát K vú), đồng thời xử lý triệt để tình trạng mất máu và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Chống Chỉ Định Tuyệt Đối Cho Bệnh Nhân K Vú Thể Nội Tiết (HR+):

- KHÔNG DÙNG THUỐC NỘI TIẾT ESTROGEN** (thuốc bổ sung nội tiết tố, viên uống mầm đậu nành liều cao, sâm tố nữ...).
- Hạn chế các liệu pháp Progestin tổng hợp liều cao đường uống kéo dài nếu không có sự phối hợp chỉ định từ Bác sĩ Ung bướu.

Phương Án Điều Trị	Phác Đồ Cụ Thể	Đánh Giá Chuyên Môn
Phương Án 1: Điều Trị Bảo Tồn (Nội Khoa)	- Uống thuốc cầm máu cơ học Tranexamic Acid 500mg (1–2 viên x 2–3 lần/ngày) trong những ngày ra máu nhiều. - Bổ sung Sắt hữu cơ Bisglycinate (30–60mg sắt nguyên tố/ngày) trong 1–3 tháng để chống thiếu máu. - Tái khám siêu âm đầu dò sau 3 tháng.	An toàn tuyệt đối cho K vú. Phù hợp nếu lượng máu ra ít và bệnh nhân muốn theo dõi tự thoái triển. Tuy nhiên không làm biến mất khối u xơ 45mm.
Phương Án 2: Phẫu Thuật Nội Soi (Khuyến Nghị Chuẩn Vàng)	Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần bảo tồn 2 buồng trứng tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành (BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV ĐHYD).	Giải quyết triệt để 100% tình trạng rong kinh & u xơ 45mm. Xóa bỏ vĩnh viễn 100% nỗi lo ung thư tử cung. Bảo tồn 2 buồng trứng: Giữ nguyên hormone sinh lý tự nhiên, không gây lão hóa sớm.

NGUỒN THAM KHẢO Y KHOA THỰC CHỨNG:

- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Neoplasms (Version 1.2024) & Breast Cancer Management.
- ACOG Practice Bulletin No. 232: Tamoxifen Use and Uterine Effects. American College of Obstetricians and Gynecologists.
- The Lancet Oncology: Endometrial changes and post-treatment bleeding dynamics following Tamoxifen cessation in breast cancer survivors.
- Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương TP.HCM: Kết quả GPB số GPB-2026 (Tăng sản điển hình khu trú nội mạc tử cung).
- Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM: Phác đồ Chẩn đoán & Xử trí Tăng sản Nội mạc tử cung & U xơ tử cung sau Ung thư.